

Die fünf Phasen der Entstehung von Bettlägerigkeit und Maßnahmen der Prävention

Phase und ihre Charakteristik	Maßnahmen
1. Instabilität Der Betroffene ist selbstständig, aber vorsichtig und wackelig, er benutzt evtl. schon Hilfsmittel oder hält sich an Möbelstücken fest, sein Bewegungsradius ist eingeschränkt, er ist sturzgefährdet. Diese Phase kann viele Jahre anhalten	Pflegefachpersonen, Hausarzt: • Informieren über die Bedeutung des Mobilbleibens • Raten zu täglichen Bewegungs- und Gleichgewichtsübungen, am besten angeleitet in einer Seniorensportgruppe • Raten zu täglicher körperlicher Betätigung, z. B. Laufen, Spaziergehen, Fahrradfahren (Dreirad), Schwimmen • Beraten zur Anpassung der Umgebung, z. B. passendes Schuhwerk, Stolperfallen im Weg und auf dem Boden entfernen • Zeigen und üben das Bewegungskonzept Kinästhetik zum Erhalt der Beweglichkeit durch kraft- und bewegungsökonomische Bewegungsmuster • Informieren zu Maßnahmen der Sturzprophylaxe
2. Ereignis Ein Ereignis tritt ein, z. B. Krankheit, Krankenhausaufenthalt, Sturz/Beinahe-Sturz, Einzug ins Altenheim. Die Beweglichkeit verschlechtert sich dramatisch, z. B. durch Angst vor Stürzen und Transfers, Patient will nicht alleine aus dem Bett kommen, nicht zu Last fallen, fehlende Orientierung	Pflegefachpersonen: • Führen häufige angenehme Mobilisationen durch, integrieren Bewegung sinnvoll mit Maßnahmen und im Tagesverlauf • Strahlen Ruhe und Sicherheit aus • Beherrschen Bewegungskonzepte (z. B. Kinaesthetics,), Transfertechniken und den Umgang mit Mobilisationshilfen Häufige gelungene Transfers können ein Dauerliegen aufhalten!

3. Immobilität im Raum Zunehmende Bewegungseinschränkung, Wechsel nur noch zwischen Bett und Sitzmöbeln, auch tagsüber im Bett, Gehen beschränkt sich auf wenige Schritte, falsch verstandene „aktivierende Pflege“ → Patient wird passiv mit dem Lifter in den Stuhl transferiert oder im Bett mit dem Laken nach oben gezogen. Spärliche und ungeeignete Sitzmöbel laden kaum zum Verweilen ein. Eile und Ungeduld von Seiten der Pflegenden → Patient will nicht zur Last fallen, zieht sich weiter zurück	Pflegefachpersonen, ggf. mit Angehörigen: • Führen regelmäßige und doch selbstbestimmte Wechsel zwischen Liegen und Sitzen durch • Verbinden jede Positionsveränderung mit einer anstehenden Tätigkeit, z. B. Körperpflege, Essen, Vorlesen einer Geschichte • Geben Patienten nie das Gefühl, dass sie zur Last fallen • Sehen Mobilisationen nicht als lästige und zeitraubende Tätigkeit • Gehen auf Ängste ein, sind zugewandt und motivierend • Lassen Patienten nicht „zu lange“ und ohne Hilfe außerhalb des Betts sitzen • Sorgen für bequeme und der Patientensituation angepasste Sitzmöbel und Hilfsmittel • Schaffen eine wohnliche Atmosphäre im Zimmer, decken z. B. das Bett am Tag ab, ziehen Tageskleidung an Durch geschickte Hilfen und positive Bewältigung kann die Bettlägerigkeit noch lange hinausgezögert werden
4. Ortsfixierung Patient kann nicht mehr selbstständig zwischen den Orten wie Bett und Stuhl wechseln, er betrachtet sich als „festgenagelt“ oder „angekettet“, nur passives Heraussetzen ändert das Gefühl nicht. Folgen: Alles wird griffbereit ums Bett platziert („sich einrichten“), von weiter entfernten Dingen verabschiedet der Patient sich; Langweile, Verlust des Zeitgefühls, Zeit spielt keine Rolle mehr, Patient döst nur noch vor sich hin, lebt zwischen Alltäglichkeiten und Verzweiflung; Besuche sind willkommen, allerdings hat der Bettlägerige kaum mehr etwas zu erzählen; Gefühl von Angewiesensein, Wartenmüssen, langsamem Sterben	Pflegefachpersonen, gemeinsam mit Angehörigen: • Sorgen für geistige Anregung und sinnvolle Beschäftigung und motivieren dafür • Schaffen angemessene Beziehung und sorgen für soziale Kontakte • Ziehen Tageskleidung am Tag an • Führen regelmäßige Transfers durch, lassen immer auch wenige Schritte zum Ziel noch gehen • Bringen den Betroffenen aus seinem Zimmer, auch nach draußen • Geben Wertschätzung und Respekt, erkennen Lebensleistungen und auch jetzigen Leistungen an, fragen z. B. um Rat, Ideen, Vorschläge, Wünsche

5. Bettlägerigkeit Patient liegt rund um die Uhr im Bett, er steht nicht mehr auf, oft wird über ihn hinweg gesprochen, es gibt keine Privatsphäre mehr, das Bett ist öffentlicher „Arbeitsort“. Er erlebt einen großen Verlust von Macht und Kontrolle über seinen Körper, sein Eigentum, über die „eigenen vier Wände“	Pflegefachpersonen, gemeinsam mit Angehörigen: • Motivieren zu möglichst viel Bewegung im Bett, leiten zu aktiven Bewegungsübungen an oder führen passive Bewegungen durch • Nutzen für jede Umpositionierung Bewegungsressourcen, z. B. Kopf drehen lassen, Bein anstellen lassen • Vermeiden unreflektiertes Gezerre und statisches Positionieren und Mobilisieren (z. B. mit dem Laken nach oben ziehen) • Respektieren das Bett als Wohn-, Schlaf-, Esszimmer des Patienten, setzen sich nicht ungefragt auf das Bett, räumen nicht ungefragt das Nachtschränkchen auf usw.
--	---

Durch professionelles Handeln kann eine Bettlägerigkeit aufgehalten oder verhindert werden. Zwar kann eine Liegepathologie immer wieder zurücktrainiert werden, doch ist die Kraftanstrengung für alle umso größer, je länger die Liegezeit andauert.

Pflegefachpersonen müssen den Prozess der Entstehung von Bettlägerigkeit kennen, wie auch Interventionsmöglichkeiten.

Unter dem Ziel der aktivierenden Pflege ist die Bettlägerigkeit häufig eine Zielverfehlung.

Menschen „heraussetzen“, die dann ortsfixiert bleiben, hat nichts mit aktivierender Pflege zu tun.

Allgemeine Pflegeziele lauten entsprechend:

- Die Muskelkraft hat zugenommen und der Kreislauf ist stabil.
- Eine optimale Mobilität ist erreicht.
- Ursachen der Immobilität sind bestmöglich beseitigt.
- Weitere Beeinträchtigungen und ungünstige Folgen der Immobilität sind verhindert.
- Die Anpassung an die veränderte Situation ist gefördert.